

老师按章节从头到尾梳理考试范围，标注重点和要求

考试题型

题型	题量	分值
选择题	20 道	每题 1 分
名词解释	10 个	每题 1-2 分
简答题	5 道	每题 1-6 分
论述题	2 道	每题 15 分

注意：论述题 15 分一道，若答题字数少于 50 字，最多只能得 5 分。务必写清楚、写详细。

名词解释（按章节整理）

第一章 绪论

- 预防医学**：在预防为主的理念指导下，通过医学工作在个体、社区和群体水平进行促进健康、预防疾病和防止劳动力过早丧失等医学实践的一门独立医学学科。
- 医学模式**：人类对健康观、疾病观及死亡观等重要医学观念的总体概括，是医学临床实践活动和医学科学研究的指导思想和理论框架。
- 健康观**：人们对健康的看法。
- 疾病自然史**：疾病不论其病因是否确定，在不进行任何治疗和干预的情况下，从发生、发展到结局的整个自然过程。

第二章 环境卫生

- 环境污染**：人为或自然因素使环境构成发生变化，扰乱生态平衡，影响健康的现象。
- 公害**：严重的环境污染。
- 生物蓄积作用**：生物个体从环境中摄入污染物的速度超过排出速度，使体内含量逐渐增加的过程。
- 生物放大**：污染物随食物链在高位营养级生物体内浓度逐级放大的现象（如 DDT 放大 100 万倍）。
- 一次污染物**：直接从污染源排放到环境中，物理和化学性质未发生变化的污染物。
- 二次污染物**：一次污染物在环境中经物理、化学或光化学反应转化生成的新污染物，毒性通常更强。

第三章 职业卫生与职业医学

- 职业性**：指劳动者在职业活动中因接触职业性有害因素而引起的健康损害或疾病。
- 职业性有害因素**：工作场所中存在或产生的、可能对劳动者健康产生不良影响的因素，包括化学性、物理性、生物性及人机工效学因素。

第四章 营养与食品卫生学

- 营养**：指人体摄取、消化、吸收和利用食物中的营养物质，以维持生长发育、组织更新和良好健康状态的动态生物学过程。
- 营养素**：指食物中可为人体提供能量、构成机体成分和修复组织以及调节生理功能的化学物质。
- 合理营养**：指全面而平衡的营养。
- 植物性化学物**：指多在植物性食物中存在的、已知必需营养素以外的具有生物活性的化学成分。
- 营养素的需要量和供给量**：也称“生理需要量”，指能保持人体健康，达到应有发育水平并能充分发挥效率完成体力和脑力活动，人体所需要的热能和各种营养素的必需量。
- EAR（平均需要量）**：满足人群中 50% 个体需要量的摄入水平。
- RNI（推荐摄入量）**：满足人群中 97% 98% 个体需要量的摄入水平，是营养目标值。
- AI（适宜摄入量）**：不能确定 RNI 时，通过观察或实验获得的健康人群某种营养素的摄入量。
- UL（最高可耐受摄入量）**：平均每日摄入营养素的最高限量，对几乎所有个体不致引起健康损害。

第八章 伤害（补充）

- 伤害**：由于能量（运动、热量、化学、电、放射线等）交换超过机体组织耐受水平造成的组织损伤，以及缺氧导致的窒息。

第一章 绪论

必须掌握：

- > 预防医学的名词解释见“名词解释（按章节整理）”章节。
- 预防医学特点（5 条）：
 - 研究对象包括个体和群体
 - 主要着眼于健康人和无症状患者
 - 研究重点为健康影响因素与人群健康水平的关系
 - 采取的策略措施更具积极意义，具有较临床医学更大的临床健康效应
 - 研究方法上更注重微观与宏观相结合
- 三级预防：名称 + 内容（不能只写名称不写内容）
 - 一级预防（病因预防/治未病）：改善环境卫生、预防接种、健康教育、健康公共政策
 - 二级预防（临床前期预防/治欲病）：早发现、早诊断、早治疗，定期体检、疾病筛查
 - 三级预防（临床预防/治已病）：规范治疗、康复训练、减少并发症、提高生命质量

小知识点（自己课后看）：

- 预防医学的研究方法
- 第一次公共卫生革命：环境卫生+个人预防 → 防治急性传染病和寄生虫病
- 第二次公共卫生革命：社会预防 → 防治慢性非传染性疾病
- 第三次公共卫生革命（1999 年 Breslow）：社会生态学模式综合预防

第二章 环境卫生（空气、水、土壤）

总论（框架与要求）

每个环境介质（空气、水、土壤）都要掌握：来源 → 种类 → 健康危害 → 防治措施

> 本章出现的环境污染、公害、生物蓄积作用、生物放大、一次污染物、二次污染物等名词解释见“名词解释（按章节整理）”章节。

第一节 空气（大气）污染

来源：工业、农业、生活、取暖、交通、其他

种类（分类）：

- 按性质分：化学性、物理性、生物性
- 化学性污染物（讲得最多）又分两类：
 - 气态污染物（5种）：SO₂、NO_x、CO、卤素化合物、含硫/含氮化合物
 - 气溶胶（4类，按粒径分）：
 - 总悬浮颗粒物（TSP）：粒径≤100μm
 - 可吸入颗粒物（PM₁₀）：粒径≤10μm
 - 细颗粒物（PM_{2.5}）：粒径≤2.5μm
 - 超细颗粒物：粒径≤0.01μm
- 按形成过程分：一次污染物、二次污染物（定义见名词解释章节）

健康危害：

- 急性危害
- 慢性危害（呼吸系统、心血管系统等）
- 远期危害：致癌、致突变
- 间接危害：酸雨、臭氧层破坏等（非特异性反应）

重大公害事件对比：

对比项	伦敦型（煤烟型）	洛杉矶型（光化学型）
污染类型	煤炭型	石油型
主要污染源	工业锅炉、家庭炉灶	汽车尾气
主要污染物	烟尘、SO ₂	NO _x 、烃类
气象条件	低温<8℃、高湿>85%	高温>23℃、低湿<75%
季节	冬季	夏秋季
健康危害	呼吸系统、心血管疾病	眼和呼吸道刺激

防治措施：

- 工业：改变原料、提高利用率、加强废气回收
- 生活：难以避免
- 农业：减少秸秆焚烧
- 结合实际灵活回答

室内空气污染

> 室内空气污染相关名词解释见“名词解释（按章节整理）”章节。> 常见室内空气污染名词解释（2个，与室外略有区别）：
> - **室内空气污染**：指由于室内引入能释放有害物质的污染源或室内环境通风不佳，导致室内空气中有害物质数量、种类不断增加，引起人体出现一系列不适症状的现象。
> - **氡**：一种无色无味的放射性惰性气体，主要来源于地基土壤和建筑装修材料，长期暴露可增加肺癌风险。

第二节 水污染

框架：来源 → 种类 → 健康危害 → 防治措施

额外重点：

- 介水传染病**：通过饮用或接触受病原体污染的水，或食用被水污染的食物而传播的疾病（需与传染病章节结合）
- 消毒**：杀灭外环境中病原微生物的方法，使水质符合饮用水各项细菌学指标的要求，防止介水传染病的发生和传播，维护人群健康
 - 消毒方法：Cl₂、ClO₂、紫外线、臭氧
- 生活饮用水基本要求**（5条）：
 - 生活饮用水中不得含有病原微生物
 - 生活饮用水中化学物质不得危害人体健康
 - 生活饮用水中放射性物质不得危害人体健康
 - 生活饮用水的感官性状良好
 - 生活饮用水应经消毒处理

第三节 土壤污染

框架：来源 → 种类 → 健康危害 → 防治措施

特点：

- 与空气、水相比，种类和健康危害基本重复
- 额外关注：**重金属**污染

重点：

- 来源较广
- 持久性强（“爆发力”）

地方病（单独强调）

碘缺乏病

- 病因**：碘摄入不足
- 临床表现**（典型2个）：
 - 地方性甲状腺肿
 - 地方性克汀病
- 防治措施**：
 - 对症治疗
 - 补碘：碘盐、碘油

地方性氟中毒

- 病因**：氟摄入过高
- 临床表现**（典型2个）：
 - 氟斑牙
 - 氟骨症
- 防治措施**（因类型不同而异）：
 - 饮水型：水源治理
 - 燃煤型：改变生活习惯（不用煤烘烤食物、不烧柴取暖）
 - 饮茶型：少喝茶

每年都有人把碘缺乏病和地方性氟中毒的病因答反！注意区分。

碘缺乏病 vs 地方性氟中毒 对比：

对比项	碘缺乏病	地方性氟中毒
病因	碘摄入 不足	氟摄入 过高
临床表现 1	地方性甲状腺肿	氟斑牙
临床表现 2	地方性克汀病	氟骨症
防治	对症治疗 + 补碘（碘盐、碘油）	因类型而异：饮水型→水源治理；燃煤型→改变习惯；饮茶型→少喝茶

其他地方病（作为了解）：

- 砷中毒 → 黑脚病
- 缺硒 → 克山病

第三章 职业卫生与职业医学（职业环境与健康）

> 职业性、职业性有害因素的名词解释见“名词解释（按章节整理）”章节。> 老师提到名词解释要掌握英文，最多 1-2 个。

- 职业病 Occupational disease
- 工作有关疾病 work-related disease
- 职业性外伤 occupational trauma

职业病诊断 4 步（所有职业病统一）：

1. 职业史
2. 现场调查
3. 临床症状
4. 实验室检查

重点职业病（临床表现 + 防治措施）：

- 铅中毒
- 汞中毒
- 一氧化碳中毒
- 苯中毒
- 矽肺

各病重点提示：

- **一氧化碳**：只需记住一个词——**樱桃红色**（症状典型、单一，只能考选择题）
- **矽肺**：虽然很重要，但课上内容不多，能考的点有限
- **重点是三个**：铅、汞、苯（临床表现 + 防治措施）

铅、汞、苯中毒对比：

职业病	典型临床表现	治疗方法	备注
铅中毒	腹绞痛、铅线、腕下垂/垂足	络合剂驱铅	—
汞中毒	易兴奋症、意向性震颤、口腔牙龈炎	驱汞治疗	—
苯中毒	慢性造血系统损害→白细胞减少→再生障碍性贫血→白血病	无特效解毒药	重点

第四章 营养与食品卫生学

这一章内容非常多，分数占比也较高，不能偷懒。

营养素（学习逻辑）

每个营养素掌握逻辑链：

1. 吃多少不会造成健康危害？（摄入量相关）
2. 健康危害是什么？
3. 改善措施是什么？
4. 来源是什么？

简答题重点：营养素的功能（老师明确提到）

营养学计算题：

- > 摄入量相关 4 个值（EAR、RNI、AI、UL）的名词解释见“名词解释（按章节整理）”章节。
- 能量换算（必须记住）：
 - 蛋白质：4 kcal/g (16.7 kJ/g)
 - 碳水化合物：4 kcal/g (16.7 kJ/g)
 - 脂肪：9 kcal/g (37.7 kJ/g)
 - kcal → kJ：乘以 4.184

重点章节

平衡膳食（核心重点）

- **平衡膳食的定义**：平衡膳食是指能够满足人体对各种营养素的需要，且各种营养素之间比例适当，能够满足人体正常生理功能需要的膳食。
- 平衡膳食的原则
- 中国居民膳食指南
- 膳食宝塔（所有内容都要掌握）

特殊人群营养（了解 2 个人群）

- 孕妇
- 老年人

注意：老师只讲了营养部分，没有讲食品部分。如果考研考营养与食品卫生学，食品部分需要自己额外学习。

第五章 流行病学（不讲，不考）

第六章 传染病

整个传染病章节的核心就是：**流行过程**

流行过程里面所有内容都要掌握

流行过程三要素

1. **传染源**：病人（最重要）、病原携带者（潜伏期/恢复期/健康携带者）、受感染动物
 - **潜伏期的流行病学意义**：追溯传染源、确定检疫期限、确定免疫接种时间、评价防制效果
2. **传播途径**（每个途径的特点）：
 - 空气传播（飞沫/飞沫核/尘埃）：冬春季高发，人口密集地区多发
 - 水和食物传播：病例有共同进食/饮水史，停止供应后平息
 - 接触传播（直接/间接）：多呈散发，家庭聚集
 - 虫媒传播：有地区性和季节性
 - 血液传播（了解）
3. **易感人群**：人群易感性升高因素（新生儿增加、易感人口迁入、免疫人口减少、新型病原体）

防治措施

按照流行过程三要素，分 3 点回答：

1. 针对传染源：**五早**（早发现、早诊断、早报告、早隔离、早治疗）
2. 针对传播途径：**消毒**（预防性消毒/疫源地消毒=随时+终末）、杀虫
3. 针对易感人群：预防接种、药物预防、个人防护

简答题/论述题务必按条理写，不要乱答。

其他小知识点（课后自己看）

- 传染病的定义
- 传染过程（病原体、宿主、环境）
- 疫源地、疫区
- 报告时限等

第七章 慢性病

慢性病的定义和特点（会定义就会特点，会特点不定义）

必须掌握的 3 个方面：

1. 慢性病的**危险因素**（吸烟、高盐饮食、缺乏运动、超重肥胖、精神心理失衡）
2. 慢性病的**防治措施**
3. 慢性病的**管理**（核心：慢性病患者的**自我管理**）
 - 自我管理**三大任务**：医疗行为管理（按时服药、锻炼）、角色管理（工作、社会交往）、情绪管理
 - 自我管理**五大技能**：解决问题、决策、寻找社区资源、建立医患关系、目标设定

管理的两个疾病（自己看细节）：

- **高血压**：诊断标准——收缩压 ≥ 140 mmHg 和/或舒张压 ≥ 90 mmHg（未服降压药情况下）
- **糖尿病**：诊断标准——空腹血糖 ≥ 7.0 mmol/L，或餐后 2 小时血糖 ≥ 11.1 mmol/L，或 HbA1c $\geq 6.5\%$
- 血糖正常值范围：空腹血糖 3.9~6.1 mmol/L；餐后 2 小时血糖 < 7.8 mmol/L

如果慢性病考得深入，会结合环境章节（如 PM2.5 的心脑血管慢性危害），或结合其他专业知识，需要有医学基础知识。

跨章节关联（考题可能综合多章）：

- 环境污染（PM2.5）→ 慢性病（心脑血管疾病）

第八章 伤害

伤害的定义（必须掌握） > 见“名词解释（按章节整理）”章节。

伤害的 3 个方面：

1. 能量：物理性、化学性、放射性等能量对人体造成的伤害
2. 缺氧导致窒息
3. 心理问题

伤害的流行病学特点：

- 不会单独考简答/论述（因为随社会不断变化，不固定）
- 作为了解

预防策略（必须掌握）：

- **Haddon 策略**：发生前（预防危险因素产生、减少数量、预防释放）、发生时（设置屏障、增强机体抵抗力）、发生后（快速检测反应、改善康复预后）
- **5E 策略**：教育（Education）+ 工程（Engineering）+ 强制（Enforcement）+ 环境（Environment）+ 评估（Evaluation）
- **主动干预**（要求宿主采取措施，如安全带）vs **被动干预**（改善环境，如安全气囊）→ **被动干预更有效**

考试注意事项

- 论述题 15 分一道，字数少于 50 字最多只能得 5 分，务必详细
- 三级预防不能只写名称，要写内容
- 传染病防治按三要素分条回答
- 营养章节一定有计算题，记住 4-9-4 和 4 个摄入量值
- 碘缺乏病 vs 地方性氟中毒的病因不要答反
- 地方病：病因、临床表现、防治措施要配套掌握